内科学含诊断学 消化系统疾病

核心精讲·肠结核 & 结核性腹膜炎

（性感认识：长期低热盗汗）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、肠结核

1.临床表现

①发热：**低热为主**，也可中热、甚至高热（伴大叶性干酪性肺炎、急性粟粒性肺结核，此时可用糖皮质激素）。约1/3 呈弛张热、少数呈稽留热

短期使用,冲击疗法

张飞拜师结盟　鸡大姐上班

②可腹泻、可便秘、也可腹泻或便秘交替

肠结核好发于回盲部　消化系统疾病要关注部位

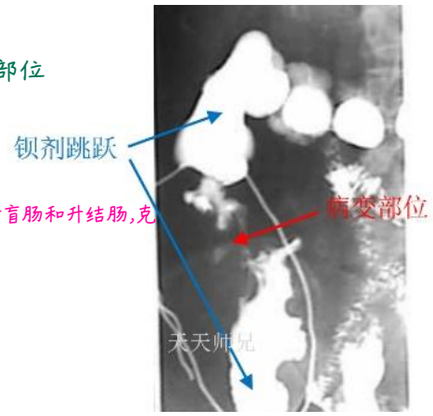
可能可能最可能：慢性低热盗汗、**右下**或脐周腹痛：

①溃疡型以腹泻为主（**多无脓血和里急后重**）毒力强,形成溃疡

②增生型以便秘和腹部肿块为主

病变在左边结肠、直肠、离肛门近,脓血多见;右边肠道出血被稀释,故脓血少见;累及直肠就会有里急后重

eg.肠伤寒好发于回肠末端,阿米巴好发于盲肠和升结肠,克罗恩好发于回肠末端和邻近结肠



2.多**经口**感染，主要来自**空洞性肺结核**

反复咽下含结核杆菌的痰液

3.**肠梗阻是肠结核、结核性腹膜炎、克罗恩病最常见的并发症**（罗姐姐）

环形溃疡,横形溃疡→瘢痕收缩

4.检查

结核

①**结肠镜（首选和金标准）**：好发于**回盲部**的**环/横形溃疡**或肿块，**干酪肉芽肿**、抗酸杆菌（还回盲盒）

②**钡灌肠**：溃疡型呈**跳跃/激惹征**（病变的上、下肠段钡剂充盈良好）钡剂刺激溃疡部位的裸露神经,肠道迅速收缩排空钡剂

③抗结核 2-6 周试验性治疗

注意：大便、痰液找到结核杆菌**不**能确诊肠结核

咽下含TB的痰液≠得肠结核

5.治疗

（1）关键：抗结核治疗，多用短程疗法 抗结核治疗不良反应大

（2）手术：①诊断困难需开腹探查者；②急性肠穿孔；③完全性肠梗阻；④慢性肠穿孔瘘管形成、不完全性肠梗阻、或肠道大出血经内科治疗无效者 易导致继发性腹膜炎

二、结核性腹膜炎

可能可能最可能：慢性低热盗汗、ttsx 多**揉面/柔韧感**。弥漫性腹膜炎，多为脐周、下腹或全腹的隐痛

《诊断学》：揉面感见于结核性腹膜炎、癌性腹膜炎、血性腹水（血液对腹膜刺激最轻微）等

VS 消化性溃疡穿孔→消化液流入腹腔→消化液对腹膜的刺激最强→刀割样剧痛、典型腹膜刺激征（压痛、反跳痛、腹肌紧张）

1.多腹腔内结核灶（肠结核、肠系膜淋巴结结核、输卵管结核）直接蔓延

女性生殖系统结核:以输卵管结核最常见

2.检查

（1）腹腔镜：金标准（广泛腹膜粘连禁用）

① 理顺检查手段:

①.粪便中检测出结核杆菌TB,不能说明患有肠结核,可能只是肺结核的患者吞下了含有结核杆菌的痰液,只有在结肠镜下观察到回盲部的环形/横行溃疡(于肠管长轴垂直)、干酪性肉芽肿,才可确诊为肠结核。

②.钡剂灌肠时,当钡剂经过肠结核的环形/横行溃疡时,刺激溃疡面裸露的神经,肠道平滑肌迅速收缩,此时钡剂迅速向下(类似于"蠕动冲"),出现一段未被钡剂充盈的肠管,称为跳跃征/激惹征。

② 理顺体征:

揉面/柔韧感并非结核性腹膜炎的特有体征,温和的刺激腹膜时均可出现,如癌性、血性腹水。

值得注意的是,揉面/柔韧感出现在肿瘤的病例题中,可理解出现的原因。在一般的病例题中,出现腹部揉面感/柔韧感,且有结核病史,可优先考虑结核性腹膜炎。

eg.比重<1.018,李凡他试验阴性,蛋白<30,细胞>500,SAAG<11

（2）**腹腔穿刺抽液**　可能患者有低蛋白血症(不要逮着一个点开跑)　一定是渗出液

①腹水呈草黄色＞淡血性＞乳糜性　VS 渗出性胸水:血清-胸水白蛋白梯度<12

③ ②**渗出液：血清-腹水白蛋白梯度 SAAG＜11、细胞＞500×10⁶/L**，多数比重＞1.018、李凡他试验(+)、蛋白＞30g/L

③**单个核细胞（淋巴细胞）为主，腺苷脱氨酶 ADA＞45 尤其 ADA2 对本病诊断有一定特异性**

④腹水培养结核杆菌阳性率很低，但可排除普通细菌、肿瘤
结核杆菌长得慢　痰涂片是确诊肺结核的首选,痰培养是确诊肺结核的金标准

（3）X 线：并发肠梗阻 阶梯状液气平

3.治疗关键：抗结核治疗，多用短程疗法

4.分型（√代表主要见于）　结核杆菌毒力较弱,机体免疫占优势,以局限修复为主　多由渗出型或粘连型 变严重→ 干酪型

	渗出型	粘连型	干酪型
发病率	√	√	
腹水	√		
明显毒血症	√		√
急腹症、穿孔、肠瘘 慢性穿孔			√
腹部肿块、延长疗程		√	√
肠梗阻		√	

腹部肿块一般是大量纤维组织包裹而来,药物不易进入→延长疗程

最常见的肠梗阻-粘连型肠梗阻　肠结核、克罗恩、结核性腹膜炎最常见的并发症就是肠梗阻

真题解析·肠结核 & 结核性腹膜炎

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2021N51 A 女性，41 岁。腹胀、低热 3 个月。既往有右侧附件区结核病史 2 年。查体：T 37.8℃，心肺未见异常，腹壁柔韧感，轻压痛，肝脾触诊不满意，移动性浊音(+)。对确诊最有价值的检查是
A.腹腔穿刺抽液检查　首先考虑结核性腹膜炎
B.腹部 CT　金标准:腹腔镜
C.腹部 B 超
D.妇科检查

优先考虑结核　直接蔓延导致结核性腹膜炎

2. 2024N51 A 男性，58 岁。右下腹痛、腹泻伴关节酸痛、低热半年。查体：T 37.5 度，心肺检查未见异常，腹软，右下腹触及可疑肿块。钡剂灌肠检查提示回盲部跳跃征。最可能的诊断是
A.肠结核
B.克罗恩病
C.阿米巴肠炎
D.肠淋巴瘤

关注部位　首先考虑结核　肠结核

3. 2025N51 A 肠结核最常见的病变部位是
A.乙状结肠
B.降结肠
C.升结肠及横结肠
D.回肠及盲肠

答案:1-3 A A D

③ 理顺知识点:
结核性腹膜炎属于炎症,在胸膜疾病章节中,我们学到因炎症导致血管壁通透性增加,液体、蛋白渗出,形成渗出液。
故结核性腹膜炎患者,因血管壁通透性性增加,液体、蛋白质可从血管壁中渗出,故腹水中蛋白质含量增加,腹水中白蛋白含量与血清中白蛋白含量的差距较小,即血清-腹水白蛋白梯度SAAG<11(VS 渗出性胸水的血清-胸水白蛋白梯度<12),其余指标为渗出液的一般规律,如细胞数目较多(细胞计数>500X10^6),且比重>1.018等。

值得注意的是,结核病人可出现低蛋白血症,使得腹水的比重<1.018,腹水蛋白含量<30,但是其细胞计数仍>500X10^6,SAAG<11。

优先考虑结核　　结核性腹膜炎多为隐痛,非刀割样疼痛

4. 2025N68-70 A 女性，34 岁。1 个月来乏力、午后低热，2 周来出现腹胀，脐周及下腹部持续性隐痛，食欲下降，大便 2-3 次/天，不成形。月经稀少、不规律，结婚 8 年未孕。查体：T 37.5℃，消瘦体型，心肺(-)，腹部膨隆，全腹有轻压痛及反跳痛，移动性浊音(+)。腹部 X 线平片示盆腔可见散在钙化影。

有妇科问题

68.最可能的诊断是 轻度,不考虑消化性溃疡穿孔所致　　结核常发生钙化

A.化脓性腹膜炎 急性、高热、刀割样疼痛

B.结核性腹膜炎

C.自发性细菌性腹膜炎 与肝硬化有关

D.腹腔恶性肿瘤 34岁不优先考虑肿瘤,而且长期低热优先考虑结核

69.该患者疾病可能出现的特征性体征是

A.腹部触诊柔韧感

B.可触及痉挛的降结肠

C.肝浊音界消失

D.可见腹壁静脉曲张

70.该患者行腹腔穿刺积液检查，对确诊最有价值的检验结果是

A.比重 1.020

B.Rivalta 试验阳性

C.有核细胞计数大于 500×10^6/L

D.腺苷脱氨酶升高 尤其是ADA2更有意义

思维导图 • 肠结核 & 结核性腹膜炎

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:4 B A D